

Von: seegarten@example.test
An: eingang-triage@spitalverbund-beispielstadt.example.test
Betreff: Austrittsbericht

Austrittsbericht

Dokumenttyp: Austrittsbericht · Eingang 15.09.2025

Patientendaten			
Patienten-ID:	SYN-PAT-000315	Fallnummer:	SYN-FALL-2026-000315
Name:	Haldimann, Nelia	Geburtsdatum:	20.09.1956
Geschlecht:	weiblich	Adresse:	Gartenstrasse 49, 3033 Waldbrunn
Kanton:	BS	Datum:	15.09.2025
Eingangskanal:	Brief-Scan	Dringlichkeit:	elektiv

Absender			
Zuweiser / Vorversorger: Gruppenpraxis Seegarten		Kontakt:	Dr. med. Mattia Rinald
E-Mail:	seegarten@example.test	Telefon:	+41 00 000 00 00

Diagnosen	
1. AZ-Verschlechterung bei Infekt unklarer Genese, aktuell regredient	
2. DM2, arterielle Hypertonie, chronische Niereninsuffizienz Stadium G3a	
3. Vorhofflimmern unter NOAK	

Verlauf	
Die Aufnahme erfolgte wegen reduzierten Allgemeinzustands und unspezifischer Beschwerden. Initial bestand eine moderate Entzündungskonstellation, die unter symptomatischer Behandlung rückläufig war. Blutdruckwerte zeigten Schwankungen, EKG ohne eindeutige Akutzeichen.	
Im Verlauf war die Mobilisation erschwert, Transfers gelangen zuletzt mit Hilfestellung. Ernährungsberatung wurde eingebunden. Die Entlassung/der Übertritt erfolgt mit Empfehlung zur engmaschigen Kontrolle der Medikation und der Nierenwerte.	
Die Patientin/der Patient wurde über Warnzeichen und Kontaktwege informiert. Einige Fremdbefunde lagen nur als Kopie vor; Originalberichte wurden beim Vorversorger angefordert.	

Medikation	
------------	--

Medikament	Stärke	Schema	Bemerkung
Atorvastatin	20 mg	0-0-1	weiterführen
Levothyroxin	75 µg	1-0-0	unverändert
Pantoprazol	40 mg	1-0-0	weiterführen
Insulin glargin	12 E	abends	bei Bedarf
Torasemid	10 mg	1-0-0	pausieren vor Eingriff prüfen
Paracetamol	1 g	bei Bedarf max. 3/d	unverändert
Metformin	500 mg	1-0-1	bei Bedarf
Prednison	5 mg	1-0-0	unverändert

Weiteres Vorgehen

Kontrolle Hausarzt innerhalb von 7 Tagen, Labor mit CRP, Hb, Krea/eGFR und Elektrolyten. Bei erneuter AZ-Verschlechterung oder Dyspnoe zeitnahe Rückmeldung. Rehabilitative Massnahmen je nach Mobilitätsverlauf prüfen.

Beilagen

Beilagen laut Schreiben: Radiologiebericht, aktuelle Medikamentenliste, Laborblatt.

Fortsetzung / Zusatzangaben

SYN-FALL-2026-000315

Zusatzangaben

Die weiteren Angaben stammen aus dem Begleitschreiben und wurden vor Eingang nicht strukturiert geprüft.
Terminrelevante Rückfragen sind möglich.

Fortsetzung / Zusatzangaben

SYN-FALL-2026-000315

Zusatzangaben

Verlaufskontrollen und Koordination mit Hausarztpraxis, Spitex oder Sozialdienst sind im Nachgang vorgesehen.